การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเสวนานโยบาย · 26 ตุลาคม 2569

ผลที่คงทนที่สุด ชี้ออกนอกกรอบ

ว่าด้วยก้าวต่อไปของการสร้างองค์ความรู้และบทบาทของนักวิชาการในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข

ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิ่งที่ได้ยินจากวงเสวนา · การตีความของคณะวิจัย

ความเห็นต่างไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข แต่อยู่ที่คำถามที่แต่ละคนถาม

1 ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน

พิมพ์ได้

[จดสิ่งที่ได้ยินระหว่างวงเสวนา]

2 ใครควรเป็นผู้จ้าง และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด

พิมพ์ได้

[จดสิ่งที่ได้ยินระหว่างวงเสวนา]

3 ใครรับภาระของความไม่เพียงพอ ระหว่าง รัฐ ผู้ทำงาน ครอบครัว และชุมชน

พิมพ์ได้

[จดสิ่งที่ได้ยินระหว่างวงเสวนา]

4 ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอ และฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

พิมพ์ได้

[จดสิ่งที่ได้ยินระหว่างวงเสวนา]

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · ความรู้สี่ช่อง

การตีความของคณะวิจัย

งานที่เคร่งครัดภายในกรอบ บอกได้ว่า เครื่องมือหยุดทำงานตรงไหน

การศึกษานี้ตั้งคำถามส่วนใหญ่ภายในกรอบที่มีอยู่ และคำตอบภายในกรอบมีคุณค่าในตัวเอง แต่เมื่ออ่านผลทุกส่วนร่วมกัน ผลที่คงทนที่สุดหลายข้อชี้ไปยังข้อจำกัดที่กรอบไม่ได้เปิดให้เปลี่ยน

ผลเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่าการศึกษาภายในกรอบผิดทาง ตรงกันข้าม มันคือผลผลิตของการศึกษาภายในกรอบที่ทำอย่างเคร่งครัด



- กรอบเต็มแล้ว ทุกหลักคิดให้ 0.337
- วางตำแหน่งถูกที่ = เพิ่ม 2.0 เท่า
- ใครจ่าย: 0.396 เทียบ 0.488
- 8 จังหวัดต่ำทุกไม้บรรทัด
- เฉพาะทาง 63.5% ในร้อยละสิบของสถานพยาบาล
- ผู้ตอบ 43% เป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัว

ผลที่คงทนที่สุดชี้ไปนอกกติกาที่เปลี่ยนได้ในรอบการจัดสรร

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · ความรู้สี่ช่อง

แผนภาพเชิงแนวคิด

สี่ช่องของความรู้: วินิจฉัยหรือเสนอทางออก ภายในกรอบหรือเปลี่ยนกรอบ

มิติแรกแยกการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไร ออกจากการเสนอว่าควรทำอะไร มิติที่สองแยกงานภายในกรอบ วินัย และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ออกจากงานที่ตั้งคำถามหรือเปลี่ยนกรอบเหล่านั้น

คำว่า radical ในที่นี้อ่านตามรากศัพท์ว่า**การแตะถึงราก** ไม่ใช่ความสุดโต่ง และกรอบสี่ช่องไม่ได้ขอให้เลือกคอลัมน์ใด แต่ถามว่าสองคอลัมน์ส่งงานให้กันอย่างไร



Lindblom · ปรับทีละน้อย เปรียบเทียบทางเลือกที่ใกล้กัน

Etzioni · กวาดตาแบบผสม: สำรวจทางเลือกพื้นฐานอย่างกว้าง แล้วลงมือทีละขั้น

radical = การแตะถึงราก ไม่ใช่ความสุดโต่ง

ดัดแปลงจากการนำเสนอของ Geoff Mulgan ในการประชุม SPA Conference 2026 · Lindblom 1959 · Etzioni 1967 · รายงานการศึกษา บทที่ 11

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · ความรู้สี่ช่อง

การตีความของคณะวิจัย

งานนี้อยู่ช่องไหน: หนักที่หนึ่งและสาม ช่องที่สี่แทบว่าง

การนับ การทดสอบตัวหาร การกระทบยอดการไหล และการสำรวจกำลังคน เป็นงานวินิจฉัยภายในกรอบ แบบจำลองจัดสรรและชุดมาตรการคงอยู่เป็นข้อเสนอภายใต้กติกาปัจจุบัน

นี่คือลักษณะทั่วไปของงานวิจัยนโยบายที่รับทุนตามวัตถุประสงค์ ตำแหน่งนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของผล แต่กำหนดว่าผลรองรับข้ออ้างชนิดใด

	ภายในกรอบ	เปลี่ยนกรอบ
วินิจฉัย	1 การนับและตัวหาร การไหลเข้าออก การสำรวจกำลังคน	2 กรอบการจัดให้มีบริการ อำนาจวิชาชีพ แรงงานดูแล
เสนอทางออก	3 แบบจำลองจัดสรร ชุดมาตรการคงอยู่	4 วงจรทบทวนรายปี เกือบว่าง

> “การศึกษาครั้งนี้กล่าวได้ว่าภายใต้กติกาที่สมมติ ทางเลือกใดให้ผลอย่างไร แต่ยังกล่าวไม่ได้ว่าการเปลี่ยนกติกาใดจะให้ผลดีกว่า และต้องแลกด้วยอะไร”
>
> รายงานการศึกษา บทที่ 11

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมช่องที่สี่ | การตีความของคณะวิจัย

ทำไมช่องที่สี่ควรมาก่อน และมีเงื่อนไขอะไร

เมื่อปัญหาอยู่ในการจัดการเชิงโครงสร้าง ความรู้เพิ่มในช่องที่สามให้ผลตอบแทนลดลง เพราะมันปรับได้เพียงภายในขอบที่โครงสร้างกำหนด

แต่ความสำคัญนี้มีเงื่อนไข ข้อเสนอเชิงโครงสร้างต้องได้หลักฐานกลไกจากช่องที่หนึ่ง คำถามว่าใครได้ใครรับต้นทุนจากช่องที่สอง และขั้นทดลองที่มีจุดตรวจจากช่องที่สาม ถ้าขาดสามสิ่งนี้ **ช่องที่สี่จะเป็นวิสัยทัศน์ที่ตรวจไม่ได้**

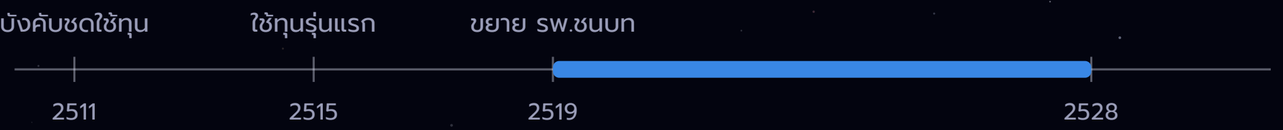
เหตุผลที่หนึ่ง · ผลของการศึกษาชี้ไปที่นั่น

กรอบคือสูตร	ไม่มีตำแหน่งรองรับ	ต่ำทุกไม้บรรทัด
0.337 ทุกหลักคิด	8,272 คน*	8 จังหวัด

* แพทย์พร้อมจัดสรรปีละสองพันห้าร้อยคน กรอบโตร้อยละห้าต่อรอบ

เหตุผลที่สอง · เวลา: "สังคมจะเลือกโดยไม่รู้ว่ากำลังเลือก"

เหตุผลที่สาม · ประวัติศาสตร์ไทย: การเปลี่ยนที่สำคัญมาจากทางเลือกเชิงโครงสร้าง



รพ.ชนบท 200 → 425 แห่ง

แพทย์ชนบท 300 → 1,162 คน

อีสาน/กทม. × 21 → × 8.6

เงื่อนไข · ช่องที่สี่ต้องได้งานจากอีกสามช่อง

หลักฐานกลไก ← ช่องที่หนึ่ง

ใครได้ ใครรับต้นทุน ← ช่องที่สอง

ขั้นทดลองที่มีจุดตรวจ ← ช่องที่สาม

ขาดสามสิ่งนี้ ช่องที่สี่เป็นวิสัยทัศน์ที่ตรวจไม่ได้



ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมช่องที่สี่ | การตีความของคณะวิจัย

หากแผนงานวิจัยในระดับชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แต่ละแผนเริ่มจากข้อจำกัดที่ผลของการศึกษาชี้ ระบุทางเลือกที่จะเปลี่ยนข้อจำกัดนั้น และบอกว่าต้องได้งานใดจากช่องอื่นก่อนเสนอผลได้

ⓘ ทั้งหมดเป็นข้อเสนอของคณะผู้เขียน ยังไม่ใช่วาระที่หน่วยงานใดรับแล้ว

1 ระบบดูแลระดับพื้นที่หลังการกระจายอำนาจ

ชุมชน

การกำกับและการเงินแบบใดรักษาที่มปฐมภูมิและเส้นทางอาชีพข้ามนายจ้างได้

รพ.สต. ในตัวอย่าง 39 จาก 76 แห่งถ่ายโอนแล้ว

2 การผลิตจากพื้นที่ที่ผูกกับเส้นทางอาชีพ

ชุมชนและเศรษฐกิจ

รับผู้เรียนจากพื้นที่ แหล่งฝึกในภูมิภาค และบันไดอาชีพ เปลี่ยนการคงอยู่ได้เพียงใด

บ้านเกิดผูกคนไว้กับพื้นที่ (ออดส์ 0.44) ไม่ใช่กับสังกัด

3 ระบบการจ้างและกรอบตำแหน่งตามพันธะบริการ

เศรษฐกิจและรัฐ

รูปแบบการจ้างแบบใดเปลี่ยนการกระจาย ความมั่นคง และต้นทุน

ใครจ่าย: 0.396 เทียบ 0.488

4 พันธะสาธารณะของบริการเอกชนและการทำงานสองภาค

เศรษฐกิจ

ระบบหลักประกันและเงื่อนไขอนุญาตทำให้เอกชนรับผิดชอบพื้นที่ขาดได้หรือไม่

เฉพาะทาง 63.5% อยู่ในร้อยละสิบของสถานพยาบาล

5 เศรษฐกิจการดูแลและการสนับสนุนผู้ดูแล

สังคมและเศรษฐกิจ

ผู้ดูแลชุมชนที่ได้ค่าตอบแทน การพักทดแทน และการดูแลระยะยาวเปลี่ยนภาระอย่างไร

ผู้ตอบ 43% เป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัว

6 การตัดสินร่วมเรื่องความเพียงพอและฐานจัดสรร

สังคม

กระบวนการตัดสินร่วมที่ใช้แบบจำลองเปิด เปลี่ยนเกณฑ์และการยอมรับผลอย่างไร

หลักคิดต่างกัน แพทย์ใหม่จังหวัดเดียวต่าง 499 คน

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · ทำให้ตรวจได้ | แผนภาพเชิงแนวคิด

ทำให้ข้อเสนอเชิงโครงสร้าง ตรวจได้

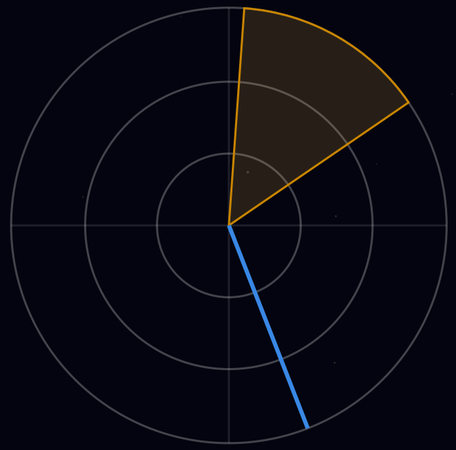
ข้อเสนอเชิงโครงสร้างต้องการเกณฑ์ที่ต่างจากการประเมินมาตรการทั่วไป เพราะมันเปลี่ยนเงื่อนไขที่การประเมินแบบเดิมรับไว้เป็นค่าคงที่

และเชื่อมระยะยาวกับระยะสั้นด้วยการกวาดตาแบบผสม จนกว่าจะมีหลักฐานจากการเปลี่ยนจริง ฉากทัศน์ที่สมมติการเปลี่ยนระบบการจ้างควรถูกเรียกว่า**การทดลองทางความคิดภายใต้เงื่อนไข**

ห้าคำถามที่ทุกข้อเสนอเชิงโครงสร้างต้องตอบ



การกวาดตาแบบผสม (Etzioni)



กวาดกว้างทุกห้าปี: สำรวจทางเลือกพื้นฐาน

ขั้นทดลองรายปี มีจุดตรวจ

ขยาย · ปรับ · หยุด ตามเกณฑ์ที่ประกาศล่วงหน้า

ระหว่างนี้เรียกว่า

การทดลองทางความคิดภายใต้เงื่อนไข

Wright 2010 · Etzioni 1967 · เกณฑ์ข้อที่สี่และห้าเป็นข้อเสนอของคณะผู้เขียน · รายงานการศึกษา บทที่ 11

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · ทำให้ตรวจได้ | การตีความของคณะวิจัย

ระหว่างรอช่องที่สี่ วาระที่เริ่มได้ทันทีในสามช่อง

งานในสามช่องแรกควรถูกออกแบบให้ส่งหลักฐานที่ช่องที่สี่ต้องใช้ ข้อมูลที่ตอบคำถามจัดสรรรอบหน้าได้ และใช้ประเมินการเปลี่ยนกติกาในอนาคตได้ด้วย ควรได้รับความสำคัญก่อน

ช่องที่ 1 · วินิจฉัยภายในกรอบ

- กระทบยอดจำนวนแพทย์ สป. กับแฟ้มเหตุการณ์เข้าออก
- เชื่อมระเบียนรายบุคคลแบบนิรนาม
- วัดเวลาทำงานจริง: ผู้ตอบ 34% คิดเกษียณก่อนกำหนดหรือลดชั่วโมงทำงาน
- เก็บหลักฐานจากผู้ที่ออกแล้ว

ช่องที่ 2 · วิพากษ์

- ใครกำหนดกรอบอัตรากำลังด้วยเหตุผลและข้อมูลใด
- ใครผลิตตัวเลขความขาดแคลนเพื่อขอทรัพยากรชนิดใด
- ตลาดเอกชนกับงานดูแลในครัวเรือนดึงคนออกจากพื้นที่ขาดอย่างไร

ช่องที่ 3 · ข้อเสนอภายใต้กติกาปัจจุบัน

- จัดสรรรอบหน้าด้วยหลายเกณฑ์
- วางตำแหน่งใหม่ตามความจำเป็นทุกรอบกรอบ
- ส่งแพทย์ใหม่ทุกปีจากตำแหน่งว่างจริง
- ประกาศกลุ่ม เวลาเริ่ม และผลที่จะวัดไว้ล่วงหน้า งานปกติจึงกลายเป็นการทดลอง

4 **ทุกงานในสามช่องนี้ควรส่งหลักฐานที่ช่องที่สี่ต้องใช้ ข้อมูลที่ตอบคำถามจัดสรรรอบหน้าได้และใช้ประเมินการเปลี่ยนกติกาได้ด้วย ควรได้รับความสำคัญก่อน**

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · บทบาทของนักวิชาการ ◐ การตีความของคณะวิจัย

นักวิชาการในช่องที่สี่ไม่ใช่ผู้ออกแบบสังคมแทนผู้อื่น แต่ทำให้ทางเลือกเปิดสู่การตรวจและการโต้แย้ง

	ภายในกรอบ	เปลี่ยนกรอบ
วินิจฉัย	1 งานวิชาชีพ	2 งานวิพากษ์ ใช้เพื่อเปิดความเข้าใจ
เสนอทางออก	3 งานนโยบาย ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า	4 งานสาธารณะ ใช้เพื่อเปิดความเข้าใจ

Burawoy · งานสี่แบบตามชนิดความรู้และผู้ฟัง
Weiss · การใช้งานวิจัยสองแบบ

บทบาท	สิ่งที่ให้	ความเสี่ยงเมื่อทำลำพัง	หลักปฏิบัติ
1 ผู้วิเคราะห์และผู้ดูแลข้อมูล	ตัวเลขที่ระบุขอบเขต ตัวหาร และความไม่แน่นอน	ถือนิยามของผู้จัดเก็บเป็นความจริง	ประกาศขอบเขตและการกระทบยอด รายงานส่วนที่อธิบายไม่ได้
2 ผู้วิพากษ์	ข้อจำกัดที่ถูกทำให้ดูเป็นธรรมชาติ และผู้ที่รับต้นทุน	หยุดที่อรรถาธิบาย ไม่ทดสอบ	ระบุกลไก ผู้กระทำ และผลที่สังเกตได้ ยอมปรับเมื่อหลักฐานไม่สนับสนุน
3 ที่ปรึกษานโยบาย	ทางเลือกที่ใช้ได้ในรอบตัดสิน พร้อมผลที่แลกกัน	ตอบคำถามผู้ว่าจ้างโดยไม่ถามว่าคำถามถูกตั้งอย่างไร	แยกระดับหลักฐาน ประกาศเกณฑ์ล่วงหน้า รายงานผลไม่ผ่าน เปิดเผยแหล่งทุน
4 ผู้ร่วมสร้างทางเลือกกับสาธารณะ	ทางเลือกระยะยาวที่ตรวจได้ด้วยเกณฑ์ที่เปิดเผย	เสนอแทนผู้อื่น หรือใช้ความน่าเชื่อถือทางวิชาการรับรองอุดมการณ์	ใช้เกณฑ์ห้าข้อ ทำงานร่วมกับผู้ทำงาน ผู้ดูแล และชุมชน บันทึกความเห็นต่าง

Weiss 1979 · Burawoy 2005 · รายงานการศึกษา บทที่ 11 ตารางบทบาทของนักวิชาการ

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · บทบาทของนักวิชาการ | การตีความของคณะวิจัย

ความใกล้ชิดกับผู้ตัดสินในบริบทไทย

ความใกล้ทำให้ความรู้ไปถึงการตัดสินได้เร็ว และเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายความสำเร็จหลายเรื่อง แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการ

หลักปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้ทำให้การศึกษาปราศจากความเอนเอียง แต่**ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าความเอนเอียงอาจอยู่ที่ใด**

Harris · การยึดรัฐเพื่อการพัฒนา

เครือข่ายข้าราชการนักปฏิรูปประดมทรัพยากรจนสถาปนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Selway · กติกาการเลือกตั้งและพรรค

ขบวนการวิชาชีพจำเป็น แต่การเมืองเชิงสถาบันชี้ขาดมากกว่า

ความเสี่ยงของความใกล้ชิด

- วาระวิจัยถูกกำหนดด้วยคำถามที่หน่วยงานถามได้ภายในอำนาจของตน
- ผู้สร้างความรู้กับผู้ตัดสินเป็นเครือข่ายเดียวกัน การตรวจจากภายนอกอ่อน
- ผู้ที่อยู่นอกเครือข่ายไม่มีช่องทางโต้แย้งเกณฑ์ที่ถูกเลือก

A4R ใช้กับนักวิชาการด้วย

- **เปิดเผย**เหตุผล
- เหตุผลต้อง**เกี่ยวข้อง**
- มี**ช่องทางอุทธรณ์**
- มี**กลไกกำกับ**

สิ่งที่การศึกษาครั้งนี้ทำแล้ว

- ✓ ประกาศเกณฑ์ตรวจแบบจำลองก่อนรัน และรายงานผลที่ไม่ผ่าน
- ✓ กำหนดผลลัพธ์หลักของการสำรวจก่อนคำนวณ
- ✓ ปรับสถานะข้อเสนอเรื่องภาระงานที่ข้อมูลไม่สนับสนุน
- ✓ เปิดโค้ดและเครื่องมือทดลองให้ผู้อื่นตรวจ
- ✓ แยกข้อมูลรายบุคคลออกจากผลที่เผยแพร่

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

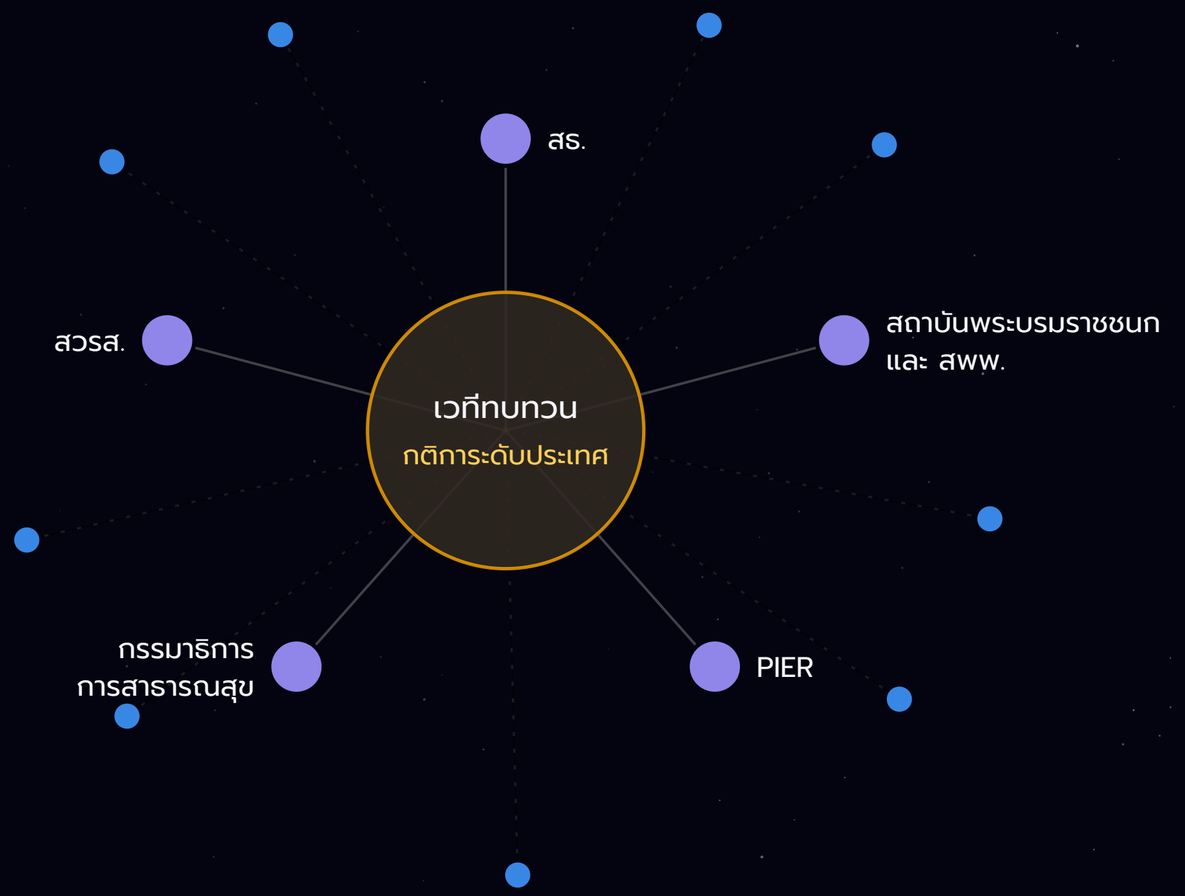
ปิด · การตีความของคณะวิจัย

สร้างสถาบันของความรู้ ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อหารือ

งานในช่องที่สี่ต้องใช้ข้อมูลระยะยาว รุ่นติดตาม และผู้วิเคราะห์ในระดับพื้นที่ ซึ่งไม่เกิดจากโครงการวิจัยครั้งเดียว

- **สธ.** ข้อตกลงข้อมูลเพื่อกระทบยอดจำนวนตั้งต้นและเชื่อมระเบียนแบบนิรนาม
- **สถาบันพระบรมราชชนก และ สพพ.** ติดตามรายรุ่นของผู้จบจากโครงการผลิตเพื่อพื้นที่
- **PIER** วิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุและแบบจำลองการเลือกของบุคลากร
- **กรรมาธิการการสาธารณสุข** เวทีติดตามการใช้หลักฐานในกระบวนการนโยบาย
- **สวรส.** เครือข่ายนักวิจัยและหน่วยงานระยะยาว

ⓘ ข้อเสนอเพื่อหารือ ยังไม่ใช่ข้อตกลงกับหน่วยงานใด



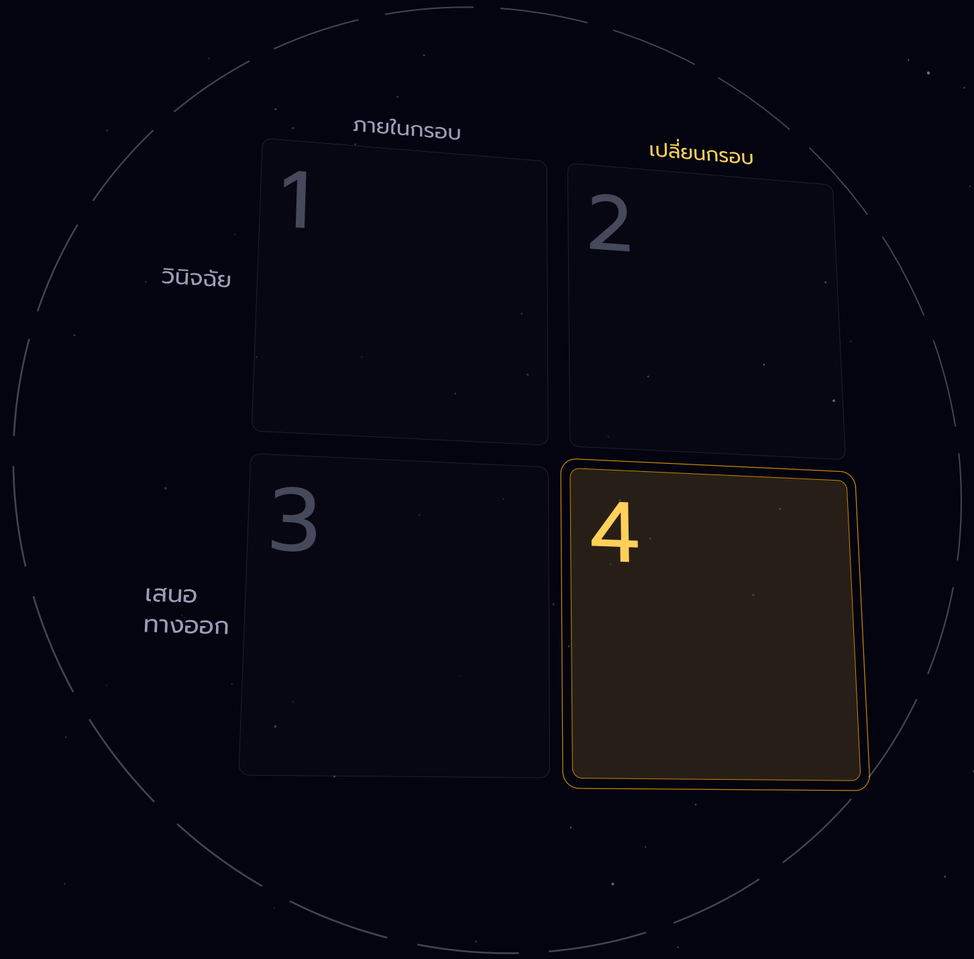
จุดเล็ก: ผู้วิเคราะห์ระดับเขตและจังหวัด ส่งผลการทดลองกลับสู่เวทีทบทวน (Ostrom)

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข้อความปิด

การตีความของคณะวิจัย

แบบจำลองไม่ได้ตัดสินใจแทนเรา แต่ทำให้ราคาของแต่ละทางเลือกปรากฏชัด



บทบาทของนักวิชาการคือทำให้การเลือกนั้นตรวจสอบได้ และเรียนรู้ต่อได้ทุกปี เพื่อให้ข้อเสนอรอบหน้ากล้าถามคำถามที่ใหญ่ขึ้น โดยยังรักษาความสามารถในการตรวจไว้ได้

ขอบคุณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะวิจัย ผู้ร่วมเสวนา และทุกท่าน

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)